Sujet - SDD 173

Spécialité : Chirurgie orthopédique et traumatologique

Date : 24/01/2026
Auteur : Yann SEBAIS, interne d'orthopédie à Rouen
Relecteur(s) : Pr Matthieu LALEVEE (PUPH Orthopédie Rouen), Hamza MAKHLOUK (VP ECOS TACFA, interne en cardiologie à Paris)

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Synthèse des résultats d'examens paracliniques Stratégie pertinente de la prise en charge
Items en lien avec la station	363- Fractures fréquentes de l'adulte et du sujet âgé 365- Surveillance d'un malade sous plâtre/résine, diagnostiquer une complication
Situation de départ en lien avec la station	173- Traumatisme des membres
Matériel nécessaire à la station	Aucun
Contexte de la station	Avec patient standardisé Box aux urgences

Pour rappel, les domaines d'apprentissage sont :

- Entretien/interrogatoire
- Examen clinique
- Iconographie
- Procédure
- Stratégie diagnostique
- Stratégie pertinente de la prise en charge
- Synthèse des résultats d'examens paracliniques
- Education/prévention
- Annonce/information au patient
- Urgence vitale
- Communication interprofessionnelle

La liste des items de l'EDN se trouve ICI
La liste des situations de départ se trouve ICI

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :

Vous êtes un.e interne en chirurgie orthopédique et traumatologique du CHU en janvier.

Vous recevez aux urgences le patient, Mr X, âgé de 40 ans, qui présente un traumatisme de sa cheville gauche par une chute purement mécanique sur du verglas.
L'interrogatoire a déjà été réalisé : pas d'antécédents, pas de traitements, pas d'allergies. Les paramètres vitaux sont normaux. Le bilan radiographique a déjà été réalisé, cf page suivante, les constantes vitales sont normales.

Consignes :

Vous avez 8 minutes pour :

- Examiner le patient
- Interpréter les radiographies
- Proposer une prise en charge dans les minutes qui suivent ainsi que dans les heures / jours suivants

Vous ne devez pas :

- Réaliser d'interrogatoire

Attention : Vous avez 8 minutes incluant la lecture de ces consignes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé.

Premières radiographies à disposition, dans un premier temps :

Radiographies à disposition <u>dans un second temps</u>, après réduction :

ECOS TACFA

GRILLE D'ÉVALUATION

Aptitudes cliniques			
1.	Rechercher des lésions associées lors de la chute (poignet crâne rachis notamment)	*1 pt*	☐
2.	Recherche d'ischémie pouls tibial postérieur ou pédieux / membre froid / recoloration des orteils – ongles – pulpe, au moins 2 éléments mentionnés.	*1 pt*	☐
3.	Recherche de déficit sensitif ou moteur en distalité	1 pt	☐
4.	Recherche d'ouverture cutanée ou de souffrance cutanée *y compris à l'arrière du membre* (moitié du pt sinon)	2 pt	☐
5.	Bon malade / bon côté / bonne date / présence d'autres radios des articulations adjacentes	1 pt	☐
6.	Fracture bi malléolaire à gauche	1 pt	☐
7.	Intertubérositaire / trans-syndesmotique / weber B / déplacée en translation latérale / trait malléolaire médial transversal / trait malléolaire latéral spiroïde, doit mentionner au moins un élément de description	1 pt	☐
8.	Nécessité de mise en place d'une analgésie / sédation légère (titration morphinique ou kétamine ou MEOPA etc…), dans les minutes	2 pt	☐
9.	Réalisation d'une réduction avec une immobilisation, dans les minutes	3 pt	☐
10.	Détaille la manœuvre de réduction (arrache botte) ou détaille la réalisation de l'immobilisation : attelle cruro-pédieuse postérieure	1 pt	☐
11.	Contrôle de la qualité de la réduction par une radiographie	1 pt	☐
12.	Surélever le membre pour diminuer l'œdème (coussin sous la jambe par exemple)	1 pt	☐
13.	Nécessité d'une chirurgie dans les heures / jours suivant si la réduction est satisfaisante et qu'il n'y a une diminution de la souffrance cutanée	1 pt	☐
14.	Nécessité d'une consultation / visite d'anesthésie en vue de la chirurgie	1 pt	☐
15.	Mise à jeun	1 pt	☐
16.	Hospitalisation pour surveillance cutanée / réalisation de la chirurgie	1 pt	☐
17.	Anticoagulation prophylactique à mettre en place (bonus, pré opératoire selon les délais avant l'intervention, post opératoire systématique)	1 pt	☐
Communications et attitudes			

10. APTITUDE À MENER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
N'explique pas au patient les gestes réalisés ou ne respecte pas le confort du patient	Explique peu les gestes réalisés	Explique les gestes réalisés et respecte le confort du patient	Donne l'information sur les gestes en expliquant les objectifs /les éléments recherchés et respecte le confort du patient	Agit sans erreur Met à l'aise

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

TOTAL	….**/19 points**

<u>Éléments de rétroaction</u> :

Les fractures bi malléolaires constituent l'une des fractures les plus fréquentes, elles ont été retirées du programme de l'EDN ***<u>écrit</u>*** mais *<u>restent présentes</u>* dans la SDD des traumatismes des membres, leur fréquence et potentielle gravité si elles se compliquent justifient le choix de cette station. La particularité de ces fractures est leur risque de souffrance cutanée majeure nécessitant souvent une réduction par manœuvres externes en urgence, afin de limiter le risque de nécrose cutanée secondaire. Les fractures bi malléolaire du sujet marchant sont presque systématiquement chirurgicales.

ECOS TACFA
SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds-« je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous avez glissé sur du verglas et votre cheville s'est « tordue » en éversion, depuis vous n'arrivez pas à marcher et êtes très douloureux. Vous ne vous êtes pas fait d'autres traumatismes.

Plan de la station ECOS :

Patient allongé sur un brancard. Examinateur en retrait sur un bureau.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Docteur, j'ai vraiment très mal …

Identité du patient :

Adulte jeune (40aine), de poids et de taille ordinaire.

Mode de vie :

Pas d'interrogatoire à réaliser.

Comportement global :

Patient douloureux à l'examen clinique avant analgésie.

Antécédents personnels : Pas d'interrogatoire

Antécédents familiaux : Pas d'interrogatoire

Médicaments : Aucun traitement

Symptômes positifs :

Douleur majeure lors de l'examen clinique
Pas de signe de souffrance cutanée, uniquement la palpation de l'esquille osseuse tibiale faisant saillie en sous cutané sur le plan médial de la cheville

Constantes :

Normales, non détaillées.

Données complémentaires :

Radiographie de face et de profil disponibles pour l'étudiant.
Si l'étudiant demande des radiographies des articulations sus et sous-jacentes, lui répondre qu'elles sont normales.

Questions de relance :

Dois-je être opéré docteur ? Demander à 5 minutes si pas de mention de la prise en charge.

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Patient allongé sur un brancard. Examinateur en retrait sur un bureau.

Matériel nécessaire à la station :

- RADIO DISPONIBLES
- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours